

Corticothérapie : choc septique & SDRA

Introduction, méthodologie & Questions 1-3



Champ de la conférence : place des glucocorticoïdes (GC) dans le choc septique et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) — traitement discuté depuis 30 ans au moment de la conférence. XXe Conférence de Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence, 12 octobre 2000, organisée sous l'égide de la SFAR avec la SPILF, la SPLF et le GFRUP, labellisée par l'ANAES. Jury présidé par F. Fourrier (Lille). **5 questions** couvrant : (1) manifestations du SDRA accessibles à la corticothérapie, (2) conséquences surrénaliennes et vasculaires du choc septique, (3) bénéfices/risques attendus, (4) indications et modalités dans le choc septique, (5) indications et modalités dans le SDRA.

Méthodologie de cotation — non-GRADE : chaque conclusion du jury combine, quand elle est disponible, un **niveau de recommandation** (1 = preuves scientifiques indiscutables ; 2 = preuves scientifiques + soutien consensuel des experts ; 3 = non reposant sur des preuves adéquates mais soutenu par les données disponibles et l'opinion des experts) et un **niveau de preuve bibliographique** sous-jacent (a = essais prospectifs contrôlés randomisés ; b = études non randomisées ou comparaisons de cohortes ; c = mises au point/revues/séries de cas ; d = publications d'opinion). **Aucune phrase du corps du texte ne porte le niveau « 3 » ni la preuve « d »** — l'échelle les prévoit mais ils ne sont concrètement utilisés nulle part dans ce document (constat par lecture exhaustive, non une omission de cette fiche).

Légende des cotations (codes imprimés tels quels par le jury)

1a	Niveau 1 + preuve a	2a	Niveau 2 + preuve a	2	Niveau 2 seul	a	Preuve a seule	N.C.	Non coté
-----------	---------------------	-----------	---------------------	----------	---------------	----------	----------------	-------------	----------

Un chip à deux caractères (« 1a », « 2b »...) reprend le code exact imprimé pour cette phrase précise — jamais la fusion de deux phrases distinctement cotées. Un chip à un seul caractère correspond à une phrase qui ne porte que l'un des deux axes dans le texte source. « N.C. » signale un passage du texte source qui ne porte aucun code entre crochets — voir encart Question 4.

Question 1 — Manifestations du SDRA accessibles à la corticothérapie

Réf.	Recommandation / constat du jury	Cotation
1.1	Les phénomènes des phases exsudative (phase 1) et de fibrose évoluée endo-alvéolaire/interstitielle (phase 3) du SDRA ne justifient pas de corticothérapie.	1a
1.2	La phase fibro-proliférative (à partir du 7 ^e jour environ) ne justifie un traitement que dans deux situations : intensité excessive de la réponse, ou durée anormalement prolongée (« late ARDS »).	2a

Physiopathologie (preuve seule) : la phase fibro-proliférative est un processus de réparation qui aboutit habituellement à la restauration d'une architecture pulmonaire normale (b), initié de façon concomitante au processus lésionnel dans un SDRA dynamique et hétérogène dans l'espace et le temps (b). Éléments de contexte non formulés comme recommandations graduées (preuve seule) : la persistance/progression de la phase fibro-proliférative se traduit par une dégradation de la compliance, une altération de l'oxygénation et une aggravation du lung injury score (LIS), sans valeur prédictive initiale (b) ; aucun signe radiologique spécifique n'existe, l'absence d'amélioration radiologique étant seulement évocatrice (b) ; la fièvre/hyperleucocytose de cette phase peut simuler un sepsis et s'associer à une défaillance multiviscérale (c) ; l'utilité pronostique des marqueurs biologiques plasmatiques/du LBA est limitée par de nombreux facteurs (1b) — certains marqueurs encore en cours d'évaluation semblent toutefois avoir une valeur péjorative (b) ; il ne faut pas transposer le modèle de la dysplasie broncho-pulmonaire du prématuré au SDRA du nourrisson (1b).

Question 2 — Conséquences surrénaliennes et vasculaires du choc septique

Réf.	Recommandation / constat du jury	Cotation
2.1	Doser systématiquement la cortisolémie avant de débiter un traitement par GC, pour dépister les rares insuffisances surrénales (IS) absolues — seuil proposé par le jury faute de valeur validée : cortisolémie de base < 10 µg/dl (≈ 275 nmol/L).	2
2.2	Ne pas réaliser systématiquement de test au Synacthène (ACTH) : la réponse normale n'est pas clairement définie au cours du choc septique et son résultat n'influence pas la conduite thérapeutique.	N.C.
2.3	En cas d'urgence absolue (ex. purpura fulminans), débiter le traitement par GC sans attendre le dosage préalable de la cortisolémie.	N.C.

2.2 et 2.3 ne portent aucun code entre crochets dans le texte source, contrairement au reste de cette question — reproduites ici comme recommandations du jury (texte explicite « le jury recommande/ne recommande pas ») avec un chip « N.C. » plutôt qu'une cotation inventée.

Corticothérapie : choc septique & SDRA

Introduction, méthodologie & Questions 1-3



Contexte (preuve seule) : le choc septique peut associer IS absolue (rare chez l'adulte), réponse surrénalienne adaptée, ou IS « relative » (cortisolémie de base normale/élevée sans réponse à l'ACTH, incidence 6–75 % selon le seuil retenu) ; la réponse vasculaire diminuée aux catécholamines endogènes impliquerait une désensibilisation des récepteurs α/β que les GC restaureraient expérimentalement (b).

Question 3 — Bénéfices attendus et risques de la corticothérapie

Réf.	Recommandation / constat du jury	Cotation
3.1	Il n'existe aucun bénéfice à un traitement précoce par GC au cours du SDRA (contrairement à leur administration en cas de fibroprolifération prolongée et/ou excessive).	a
3.2	Dans le choc septique, seule l'utilisation de faibles doses d'hydrocortisone est bénéfique : diminution attendue de la mortalité, amélioration hémodynamique (baisse de la fréquence cardiaque, hausse des résistances artérielles systémiques et de la pression artérielle moyenne) permettant un sevrage plus rapide des amines vasoactives.	a
3.3	Avant de débiter la corticothérapie (SDRA comme choc septique), rechercher systématiquement une infection ; en cas d'infection bactérienne, prescrire une antibiothérapie adaptée au moins 3 jours avant de débiter les GC.	2
3.4	Surveiller la glycémie pendant toute la durée du traitement par GC (intolérance glucidique, en particulier chez l'enfant).	2

Risques (contexte, non formulés en recommandation graduée) : à doses cumulatives élevées, la corticothérapie augmente le risque infectieux — les faibles doses cumulatives d'hydrocortisone du choc septique ne semblent pas majorer ce risque ; l'absence de fièvre sous traitement ne permet pas d'éliminer une infection, en particulier pulmonaire (b) ; le risque d'hémorragie digestive ne semble pas accru (données prospectives insuffisantes) ; risque de neuromyopathie pour des doses cumulatives > 1000–1500 mg de méthylprednisolone (MP), le plus souvent associées aux curares.

Corticothérapie : choc septique & SDRA

Question 4-5 — Protocoles pratiques & traçabilité



Question 4 — Indications et modalités dans le choc septique

Anomalie source divulguée : à la différence des questions 1 à 3, aucune phrase de cette question ne porte de code entre crochets dans le texte source — le protocole ci-dessous est la reproduction fidèle du texte du jury, présenté ici avec un chip « N.C. » (non coté) plutôt qu'une cotation inventée.

Réf.	Recommandation / constat du jury	Cotation
4.1	Indication : choc septique de gravité particulière, nécessitant des doses élevées et/ou croissantes d'agents vaso-actifs du fait d'une hypotension persistante malgré un remplissage vasculaire jugé satisfaisant. Avant traitement : s'assurer du caractère approprié de l'antibiothérapie et de l'absence d'indication chirurgicale d'éradication d'un foyer infectieux — le traitement peut alors être instauré, y compris plusieurs jours après l'installation du choc.	N.C.
4.2	Posologie : hémisuccinate d'hydrocortisone 200 à 300 mg/j, en perfusion continue ou répartis en 3–4 injections IV, après prélèvement pour dosage de cortisol (des inducteurs enzymatiques/substrats du cytochrome P3A4 peuvent modifier le taux sanguin). Chez l'enfant : 100 mg/m ² /j en 4 injections/6h, dès que possible en cas de purpura fulminans.	N.C.
4.3	Durée : au moins 5 jours en cas de réponse clinique, avec réduction progressive puis arrêt à la disparition des signes de choc (sauf exceptionnelles IS absolues). Au-delà de 72 h sans réponse hémodynamique (hausse de la PA, stabilisation/sevrage des vaso-actifs), arrêter le traitement.	N.C.
4.4	Surveillance : glycémie, natrémie, kaliémie. La modification des signes systémiques d'inflammation sous GC peut masquer une surinfection.	N.C.

Question 5 — Indications et modalités dans le SDRA

Réf.	Recommandation / constat du jury	Cotation
5.1	Une corticothérapie n'est indiquée ni en prévention d'un SDRA, ni à la phase initiale de son évolution ; à ce stade, elle augmente l'incidence des infections et le taux de mortalité.	1a
5.2	Une corticothérapie peut se discuter à la phase fibro-proliférative, chez un nombre restreint de patients : SDRA évoluant depuis 7 jours au moins, avec LIS $\geq$ 2,5, sans amélioration malgré une prise en charge adéquate.	2a
5.3	Aucun marqueur biologique validé ne permet de poser l'indication des GC à ce stade.	a
5.4	Une biopsie pulmonaire systématique n'est pas justifiée avant l'instauration des GC (risques non négligeables et absence de bénéfice documenté).	2b
5.5	Posologie : méthylprednisolone (MP) 2 mg/kg/j en 4 injections IV, débutée entre le 7 ^e et le 10 ^e jour d'évolution du SDRA, poursuivie 3 à 4 semaines puis arrêtée progressivement (risque de rebond). Amélioration attendue entre le 5 ^e et le 14 ^e jour (clinique, LIS en baisse de plus d'1 point, régression des défaillances viscérales) ; recherche systématique d'une infection surajoutée pendant tout le traitement. Chez le nourrisson/l'enfant : protocole identique proposé, en l'absence de données spécifiques exploitables.	N.C.

5.3 (preuve seule, « a ») et 5.4 (recommandation graduée « 2b ») sont deux phrases consécutives du texte source portant deux cotations distinctes — reproduites ici en deux lignes séparées plutôt que fusionnées en un seul chip composite. 5.5 ne porte aucun code entre crochets dans le texte source (même anomalie qu'à la Question 4).

Sources et traçabilité

Document source : XXe Conférence de Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence « Corticothérapie au cours du choc septique et du SDRA », 12 octobre 2000. Jury présidé par F. Fourrier (Lille) ; coordonnateur du Bureau du Consensus : F. Saulnier (Lille). Organisée par la SFAR avec la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, la Société de Pneumologie de Langue Française et le Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques. Conférence labellisée par l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé).

Méthodologie : cotation à deux axes indépendants — niveau de recommandation (1/2/3) et niveau de preuve bibliographique (a/b/c/d) — non-GRADE. Voir légende page 1. Niveau « 3 » et preuve « d » définis par l'échelle mais non utilisés dans le corps du texte.

URL source : <https://sfar.org/corticotherapie-au-cours-du-choc-septique-et-du-sdra/>

Corticothérapie : choc septique & SDRA

Question 4-5 — Protocoles pratiques & traçabilité



Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations et constats gradués des 5 questions de la conférence de consensus, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par la SFAR. Conférence de 2000 : se référer également, en complément, aux données et pratiques plus récentes sur la corticothérapie du choc septique (ex. essais randomisés postérieurs à cette conférence) et à un avis spécialisé en cas de doute.